Primaire borstreconstructie

Veel patiënten die borstkanker hebben of hebben gehad, komen in aanmerking voor een vorm van borstreconstructie. In deze folder leest u meer over de primaire of directe borstreconstructie. Deze vindt plaats tijdens dezelfde operatie als het verwijderen van de kwaadaardige tumor. De oncologisch chirurg en plastisch chirurg opereren dan meestal gezamenlijk om een zo mooi mogelijk resultaat te bereiken. Een primaire borstreconstructie kan gebeuren met eigen weefsel of met een prothese.

De behandeling

Borstsparende operatie

Als er een borstsparende operatie wordt uitgevoerd door de oncologisch chirurg, dan is het soms mogelijk om de vorm van de borst weer te verfraaien met eigen weefsel. De holte die ontstaat na het verwijderen van de tumor, wordt door de plastisch chirurg weer opgevuld met eigen (borst)weefsel.

Borstsparende operatie met borstverkleining

Bij vrouwen met een grotere cupmaat (vanaf C/D) kan een zogenaamde oncoplastische reductie (verkleining) uitgevoerd worden. Er wordt gebruik gemaakt van de borstverkleinende techniek. We zorgen dan dat de tumor zich bevindt in het stukje borst dat wordt verwijderd. Daarna wordt de borst weer vormgegeven. Daarbij vullen we de ontstane holte op met eigen borstweefsel. Het voordeel van deze techniek is dat de borst een fraaie vorm heeft en die ook behoudt na de bestraling. De borst zal echter wel altijd iets van vorm veranderen door de bestraling. De andere borst kan in dezelfde sessie direct verkleind worden, maar we kunnen ook wachten tot na de bestraling, in verband met kans op ongelijke borsten.

Het is belangrijk dat de tumor in zijn geheel is verwijderd. Is dat niet het geval, dan krijgt u soms een extra dosis bestraling of u moet opnieuw geopereerd worden.

In de meeste gevallen zal dit een borstamputatie zijn. Dat komt doordat het borstweefsel verplaatst is. Hierdoor is meestal niet meer goed te beoordelen waar de rest van de tumor zit.

Borstsparende operatie met invoegen eigen weefsel

Bij vrouwen met een kleinere cupmaat of ongunstige locatie van de tumor is het mogelijk om weefsel uit de directe omgeving van de borst te gebruiken om de ontstane holte op te vullen. Dat doen we met een zogenaamde lokale transpositielap: we vullen de ontstane holte op met een stuk huid en vetweefsel van de flank of van onder de borst. U kan hierdoor een langer litteken krijgen dat loopt over de flank richting de rug.

Borstamputatie

Als het oncologisch gezien niet veilig of wenselijk is om een borstsparende operatie uit te voeren, kan de borst verwijderd worden. Dit noemen we een borstamputatie. Bij een borstamputatie zijn er twee manieren om een nieuwe borst te maken: met een prothese of met lichaamseigen weefsel.

Reconstructie met tissue-expander en / of prothese

Als al het borstweefsel weggehaald moet worden, wordt de huid bij een directe reconstructie meestal gespaard. Tegenwoordig kan de tepel soms ook gespaard blijven, afhankelijk van de plaats van de tumor.

Soms kunnen we direct een siliconen prothese inbrengen. Bij een borst groter dan een B- cup, een mindere huidkwaliteit of als iemand een grotere cupmaat wenst (indien mogelijk) moet de huid (en soms de borstspier) eerst worden opgerekt. Daarvoor gebruiken we een tissue expander. Dit is een speciaal soort ballonnetje van siliconenmateriaal, dat we in de weken tot maanden na de operatie opvullen. De huid (en spier) rekken hierdoor langzaam op, zodat er een holte voor de prothese ontstaat. Als het gewenste volume is bereikt, wordt in een tweede operatie de tissue expander verwisseld voor de definitieve prothese. Soms plaatsen we ook een tissue expander voor een reconstructie met lichaamseigen weefsel.

Als u na de operatie nog bestraling krijgt, is de ingreep met een tissue expander of prothese minder geschikt. Wij opereren namelijk liever niet in bestraald gebied. Ook bestralen we liever niet op een tissue expander of prothese vanwege de kans op wondproblematiek en kapselvorming rond de prothese.

Reconstructie met lichaamseigen weefsel

In sommige gevallen is het mogelijk om tijdens de ingreep van de borstamputatie direct een reconstructie te maken van lichaamseigen weefsel. Dit gebeurt in de meeste gevallen met een DIEP – lap. De DIEP-lap is een methode waarbij er een nieuwe borst wordt gemaakt met huid en vet van de buik. Dit is een gecompliceerde ingreep, omdat de aders en slagaders van de buiklap met behulp van een microscoop op de gewenste plaats moeten worden aangesloten.

Symmetrie

Na een reconstructie van de borst kan, als nodig, de andere borst kleiner of groter gemaakt worden om zoveel mogelijk 2 gelijke borsten (symmetrie) te krijgen. De borsten zullen echter nooit geheel gelijk worden. Dit komt mede doordat de borsten voor de operatie vaak ook niet geheel gelijk waren, en omdat er mogelijk verschillende operatietechnieken per borst worden gebruikt.

Tepelreconstructie

Als we ook de tepel moeten verwijderen, dan is soms een tepelreconstructie mogelijk. Dit gebeurt nooit tijdens de ingreep waarbij de tumor/borst wordt verwijderd. De tepel kan op verschillende manieren worden gereconstrueerd. U kunt als mogelijk kiezen voor een tepelreconstructie en aanvullende tepeltatoeage. Bij een lokale reconstructie wordt de huid van de gereconstrueerde borst gebruikt om een tepelknopje te maken. Dat gebeurt met een speciale techniek, tijdens een kleine ingreep. De ingrepen worden uitgevoerd onder plaatselijke verdoving in een poliklinische setting of onder narcose gelijktijdig met andere (kleine) correcties. Als de tepelreconstructie klaar is, kan er na een aantal maanden een tepelhof omheen getatoeëerd worden. U kunt er ook voor kiezen om alleen een tepeltatoeage te laten plaatsen.

Risico's en complicaties

Wij doen ons best om uw operatie met de grootste zorg uit te voeren, maar bij elke operatie is er een kans op complicaties zoals: allergische reactie op gebruikte verdovingsvloeistoffen of materialen,

bloeduitstorting, nabloeding, wondinfectie, ontstaan van een hypertrofisch litteken en trombose. Deze complicaties komen echter weinig voor. Rond de littekens kan de huid gevoelloos raken en dit kan geruime tijd zo blijven. In enkele gevallen keert het gevoel rondom de littekens niet of niet helemaal terug. Verstoorde wondgenezing en afsterven van weefsel komen zelden voor. Deze verschijnselen kunnen leiden tot een tegenvallend resultaat. Soms start de bestraling daardoor later. Absolute symmetrie (gelijke borsten) bij operaties is niet te garanderen. Een gereconstrueerde borst is altijd anders dan een eigen, natuurlijke borst, zowel in gevoel als hoe het eruit ziet.

Deze risico's en complicaties, evenals het belang van het stoppen met roken (indien van toepassing) zijn tijdens het consult met de arts met u besproken. Per type operatie zijn er altijd nog behandelings specifieke complicaties die met u zijn of worden besproken. Deze zijn ook te vinden in de patiëntenfolder over de betreffende ingreep. Hoewel de operatie met de grootste zorg zal worden uitgevoerd, verschilt het genezingsproces per individu en is het voor ons niet mogelijk om garanties te geven.

Tot slot

Als u vragen heeft na het lezen van deze folder of na de ingreep, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Plastische Chirurgie.

De polikliniek Plastische Chirurgie locatie Zoetermeer is bereikbaar:

- van maandag tot en met vrijdag
- van 08.00 tot 16.00 uur
- via telefoonnummer: (079) 346 28 04

De polikliniek Plastische Chirurgie locatie Den Haag is bereikbaar:

- van maandag tot en met vrijdag
- van 08.00 tot 16.00 uur
- via telefoonnummer: (070) 210 7760

Wat vindt u van deze patiënteninformatie?

Wij horen graag uw mening over deze folder. Wilt u na het lezen enkele vragen beantwoorden? U vindt de vragen via deze link: https://folders.hagaziekenhuis.nl/2228. Dank u wel.

Spreekt u geen of slecht Nederlands?

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Do you speak Dutch poorly or not at all?

This brochure contains information that is important for you. If you have difficulty understanding Dutch, please read this brochure with someone who can translate or explain the information to

you.

Czy Państwa znajomość języka niderlandzkiego jest żadna lub słaba?

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Hollandaca dilini hiç konuşamıyor musunuz veya kötü mü konuşuyorsunuz?

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilinde zorlanıyorsanız, bu broşürü, size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

إذا كنتم لا تتحدثون اللغة الهولندية أو تتحدثونها بشكل سيء إن المعلومات الموجودة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كانت لديكم صعوبة في اللغة الهولندية، فاحرصوا عندئذ على قراءة هذا المنشور مع شخص يترجم المعلومات أو يشرحها لكم.

553313012026